

Review 类文章均需审核内容

审查维度	审核关键点	报告到位/不到位
*重复率	1. 重复率<20%: 不止关注数字, 查看是否存在直接复制、抄袭等现象	
* PASS原则	2. 评估文章价值、创新性、科学性、可阅读性 【临床价值】 主题重要性是否夸大（是否有遗漏的信息）； rational是否立得住。 【创新性】 是否已有类似研究，明确本文的创新性。 【科学性】 （1）主题一致性：检查标题、摘要、主体，有无主题过于宽泛但主要内容探讨较窄的问题； （2）可靠性：正文是否报告重要结果的具体数据而不是模糊陈述；结论是否基于严谨的逻辑推理得出，具有说服力； （3）期刊匹配度：全文相关内容是否与期刊scope匹配（比如，VATS期刊稿件全文综述微创手术）； （4）综述深度：是否仅是描述而不做任何点评，有无分析现有的gap、不一致结果、积极消极影响、证据匮乏等问题； （5）综述广度：是否尽量cover重要相关文献，还是有选择地总结（比如，有意忽视该领域一些重要的RCT研究）。 【可阅读性】 （1）是否结构清晰、逻辑通顺、图表清晰； （2）研究内容是否focus（避免又臭又长）； （3）除了大量的文字描述，是否提供图表可视化，以便读者阅读、理解。	

	3.1 判断文章属于Review还是OA：明确文章的主要价值是“基于文献的经验总结归纳”还是“原创设计”	
	3.2 区分Review类型：见下图 <pre> graph TD RA[Review Article] --> Q1{文献检索是否系统， 并纳入了系统评价类研究？} Q1 -- 是 --> OR[Overview of Reviews] Q1 -- 否 --> Q2{文献检索是否系统、全面？} Q2 -- 是 --> Q3{是否对纳入研究进行了质量评估 (例如，偏倚风险)？} Q3 -- 是 --> SR[Scoping Review] Q3 -- 否 --> SysR[Systematic Review] Q2 -- 否 --> Q4{文献检索是否有时间限制？} Q4 -- 是 --> RR[Rapid Review] Q4 -- 否 --> Q5{文章字数是否较少？} Q5 -- 是 --> MR[Mini Review] Q5 -- 否 --> Q6{是否是基于专家观点、 意见或经验的文献讨论？} Q6 -- 是 --> CPR[Clinical Practice Review] Q6 -- 否 --> NR[Narrative Review] </pre>	
* 文章类别判定		
图表	4.1 图表数量是否超出要求，是否都在文中引用，是否过于冗余	
	* 4.2 图表中数据和正文/摘要/引文是否均一致，图表中是否出现应该有但是空出来的数据缺失情况	
	4.3 图/表是否信息完整：题，标准差等重要的统计学呈现， 独立成文的Footnotes等	
	* 4.4 图表是否太丑、太分散、分辨率太低而有美化空间	
	4.5 图表是否为原创，或已取得版权许可，包括 CCBY等授权协议	

参考文献	* 5.1 是否在应有参考文献的地方缺少文献（如，出现数字、人名、previous study等要有参考文献，several/some studies等表述需引用多篇文献，表格中纳入的原始研究最好在表格中注明参考文献等）	
	* 5.2 是否赘述引用（如，一般某论点的引用文献最好不超过 10 篇）	
	* 5.3 是否存在严重自引和过度引用本期刊文章的问题	
	5.4 检查参考文献列表中文献数量与正文是否一致	
	* 5.5 参考文献须有近 3 年文献确保内容不过时，最好 20%以上标准，但占比要据类型定	
	* 5.6 参考文献列表里是否存在未经同行评议的、撤稿的、已发表但标注 publish online 的	
	* 5.7 文章正文对参考文献的描述与源文献的内容（稿件类型和具体意思等信息）不一致情况（多处出现提示 AI 撰稿更大的可能性）	
其他	6.1 缩写（遗漏、重复、前后一致）	
	6.2 格式（拼写、英文字符、三线表、高清图）	
	6.3 政审	
	6.4 涉及伦理则报告	
	6.5 包括摘要后的总字数：Narrative Review 和 Clinical Practice Review 字数<6000，Mini Review 字数<3000	

AME Narrative Review 审核清单

审查维度	审查关键点（按照审核顺序排列）	报告到位/不到位
题目	1. 重点突出，涵盖全面；定位明确（Narrative Review）；更新类综述需在标题中明确标注updated（建议在题目中表明检索的具体时间范围）	
摘要	2.1 Background and Objective: 简述研究背景，陈述做此综述的缘由，明确综述目标	
	2.2 Methods: 简述搜索策略，如数据库、时间框架和语言考虑因素	
	2.3 Key Content and Findings: 描述文献综述的主要内容和主要发现	
	2.4 Conclusions: 描述主要结论以及综述可能对未来研究、临床实践和政策制定产生的潜在影响	
关键词	3. 数量（3-5个）、内容（与主题密切相关）	
引言	4.1 Background: 详细描述研究背景，如疾病 / 药物的背景（流行病学，当前治疗的局限性等）	
	4.2 Rationale and knowledge gap: 撰写综述的原因、现存文献不能解决的问题（knowledge gap，即本综述的创新之处）	
	4.3 Objective: 具体目标（aim to/objective is）	
	4.4 遵循 Narrative Review 清单声明	
方法（文和表中均得报告）	5.1 检索日期：是否具体到年月日	
	5.2 检索时间范围：是否具体到年月日，不能模糊表述（如，近十年、21世纪、2022年、不限时间），建议写成2010.1-2022.4	
	5.3 数据库：一般不要求多个数据库，除非与作者的综述目的相违背（如，希望探讨国际情况，且作者是中国人，却缺少中文数据库）	
	5.4 检索词和检索策略： (1) 检索词是否涵盖本综述讨论范围（如，希望探讨肺癌，但检索策略仅包括NSCLC） (2) 检索策略是否以补充表的形式单独呈现，或是否用布尔运算符AND/NOT/OR连接检索词来呈现	
	5.5 纳排标准（研究类型、语言）	
	5.6 筛选文献过程（谁、是否独立展开、取得共识的方法等）：仅在作者贡献中报告不算	
主要内容	6 概述文献结果、评价纳入文献局限性和/或质量、总结本综述的优势与局限之处、提出未来研究想法、总结图表	

结论	7 本综述对临床实践、政策或未来研究的意义	
----	-----------------------	--

AME Mini/Clinical practice Review 审核清单

审查维度	审查关键点（按照审核顺序排列）	报告到位/不到位
题目	1. 重点突出，涵盖全面；定位明确（标题中体现出为CPR，如，clinical/experience）	
摘要	2. 简述研究背景，陈述做此综述的缘由，明确综述目标，总结主要发现，表明临床意义或未来研究方向	
关键词	3. 数量（3-5个）、内容（与主题密切相关）	
引言	4.1 Clinical practice review 结构化（Background、Rationale and knowledge gap、Objective）	
	4.2 内容要求：详细描述背景、撰写综述的原因、现存文献不能解决的问题（knowledge gap）、具体目标	
主要内容	5.1 Mini review：针对讨论的关键问题，概括已有文献结果、评价纳入文献局限性和/或质量、总结本综述的优势与局限之处、提出未来研究想法、总结图表（非强制性，视情况而定）	
	5.2 Clinical practice review：概括已有文献的重要发现，评价纳文献局限性和/或质量，总结自身临床经验，为临床实践提供指导建议，总结图表（非强制性，视情况而定）	
结论	6. 本综述对临床实践、政策或未来研究的意义	

Update: 2025.6.11